

SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Gillen Oarbeascoa Royuela, Elena Landete Hernandez, Javier Ortiz Martin.

INTRODUCCIÓN

Los síndromes mielodisplásicos son enfermedades hematológicas clonales adquiridas caracterizadas por la presencia de una o más citopenias (anemia $<10.5\text{g/dL}$, trombopenia $<100.000/\text{mm}^3$ y neutropenia $<1.500/\text{mm}^3$) junto a rasgos displásicos. Su prevalencia aumenta exponencialmente con la edad.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de certeza del Síndrome Mielodisplásico únicamente puede establecerse mediante el aspirado/biopsia de médula ósea.

No obstante, puede sospecharse su existencia mediante los estudios analíticos convencionales:

- Anemia: Es la citopenia más frecuente en los SMD. Habitualmente es macrocítica. Puede ser grave y precisar transfusión de hemocomponentes.
 - Sospecharemos un SMD ante toda anemia macrocítica en pacientes sin causa (hepatopatía, hipotiroidismo, causas carenciales B12-Folato).
- Trombopenia: Presente en $\frac{1}{4}$ de los casos de forma aislada. Grados variables de trombopenia, habitualmente asintomática. Puede presentar plaquetas de gran tamaño (con falsa trombopenia).
 - En ocasiones puede cursar con hemorragias con contajes normales derivados de una **trombopatía adquirida** (plaquetas disfuncionales).
- Leucopenia: presente en 50% de los pacientes, prácticamente a expensas de **neutropenia** ($<1.500/\text{mm}^3$).
 - Se asocian a una mayor predisposición a sufrir infecciones.
 - La neutropenia severa ($<500/\text{mm}^3$) se asocia a un mayor riesgo de infecciones.
- Pancitopenia en el 50% de los casos.

El frotis de sangre periférica mostrará rasgos displásicos en la sangre.

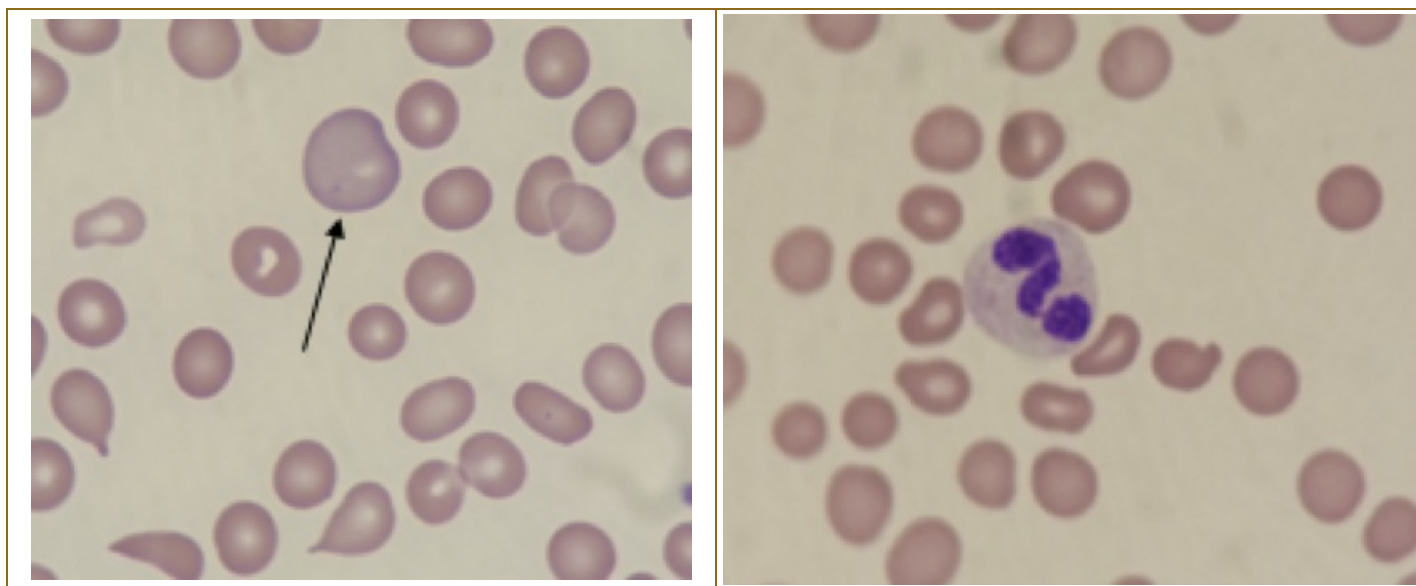
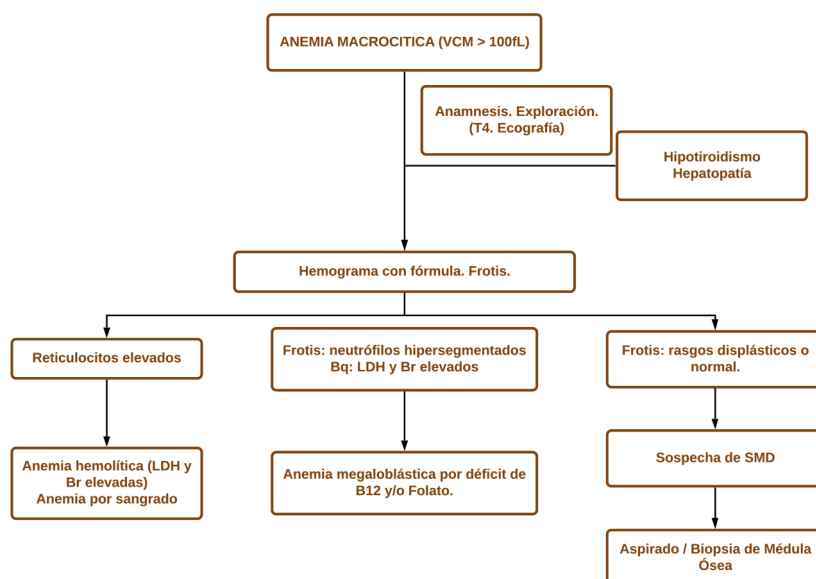


Imagen 1: rasgos displásicos de serie roja. Presencia de un macroovalocito (flecha) y varios dacricitoitos.

Imagen 2: neutrófilo hipogranular, un signo frecuente de displasia.



TRATAMIENTO

El manejo y tratamiento de un SMD en Urgencias se basará en una adecuada terapia de soporte y de las complicaciones que haya desarrollado. El aumento marcado (en poco tiempo) de los requisitos transfusionales (sean de hematíes o plaquetas) o el desarrollo de neutropenia profunda, una vez excluidas otras causas secundarias, puede indicar la progresión del SMD a formas más agresivas o su transformación en Leucemia Aguda.

Recomendaciones para la transfusión en SMD:

- **Transfusión de hematíes:** debe guiarse por los síntomas relacionados con la anemia, para una Hb 7-8g/dL, salvo en pacientes con cardiopatía (8-9g/dL).
- **Transfusión de plaquetas:** el sangrado es la 2ª causa de muerte en SMD.
 - Paciente estable: <10.000/mm³.
 - Paciente con factores de riesgo (fiebre, infección, inestabilidad): <20.000/mm³.
 - Intervención invasiva: <50.000/mm³.
 - Intervención ocular/SNC: <100.000/mm³.
 - Puede plantearse la punción lumbar con niveles inferiores (75.000/mm³).
- **Otras terapias de soporte:**
 - Antifibrinolíticos (Ac. Tranexámico): en caso de sangrados mucosos leves en trombopenia.
 - Aislamiento inverso en pacientes con neutropenia severa (<500 neutrófilos/mm³).
 - Antibióticos: mismas recomendaciones en neutropenia febril (ver capítulo Pancitopenia). Las infecciones suponen la causa principal de muerte en SMD.

PUNTOS CLAVE A RECORDAR

- Los SMD cursan con citopenias variables. La más frecuente es la anemia macrocítica.
- Los pacientes con SMD tienen mayor riesgo de sufrir infecciones. Las infecciones son la primera causa de muerte.
- La progresión a Leucemia Aguda puede presentarse como un empeoramiento de

parámetros hematológicos o un aumento de requisitos transfusionales.

REFERENCIAS

- Hoffbrand's Essential Haematology, Seventh Edition. By A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss. Published 2016 by John Wiley & Sons Ltd. 180-185.
- Castro Quismondo N., Pérez Rial G. En: Aguilar Rodríguez F., Bisbal Pardo O., Gomez Cuervo C., de Larga Sebastian M., Maestro de la Calle G., Perez-Jacoiste Asin M.A., Perez Ordoño L., Vila Santos J. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. 7ª edición. Madrid: Hospital Universitario 12 de Octubre, 2012. 1061-1069.